

Aneurisma de aorta abdominal - ruptura

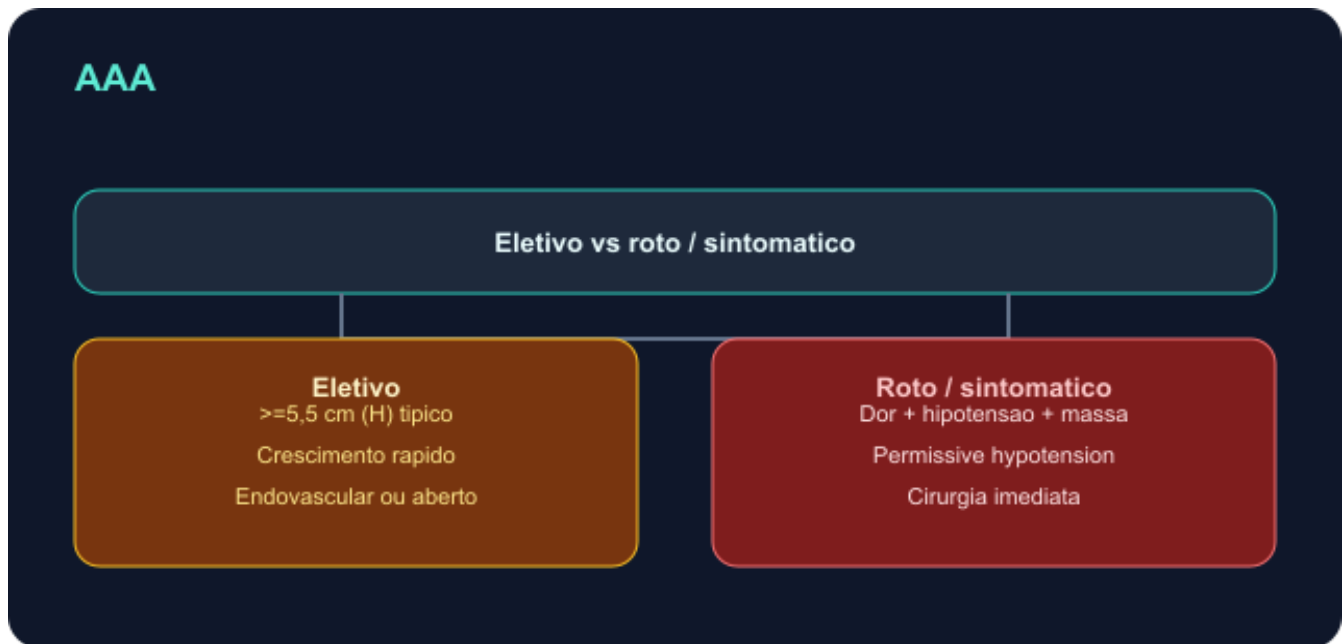
AAA sintomático ou roto é emergência vascular. Eletivo repara-se tipicamente a partir de ~5,5 cm (homem) ou crescimento rápido/sintomas — confirme o critério da banca.

Tríade da ruptura

Dica - Tríade da ruptura

Dor abdominal/lombar + hipotensão + massa pulsátil. Nem sempre completa — em idoso tabagista com síncope e dor lombar, pense AAA.

Dois mundos: vigilância/reparo programado versus sala de emergência e reanimação permissiva.



Conduta

- Roto: acesso venoso grosso, tipagem, não buscar normotensão agressiva (hipotensão permissiva)
- TC só se estável o suficiente e diagnóstico incerto; instável vai direto à cirurgia se alta probabilidade
- EVAR vs aberto conforme anatomia, estabilidade e expertise
- Rastreio: homens idosos tabagistas — USG (protocolos de prevenção)

Limiares úteis

Situação | Conduta típica

<4–4,5 cm | Vigilância com imagem

≥5,5 cm (&B) | Indicação eletiva frequente

Sintomático | Reparar (urgência)

Roto | Emergência operatória

Armadilha de prova

Atenção - Armadilha de prova

Não faça colonoscopia/endoscopia ou reposição volêmica agressiva buscando PA 'normal' no AAA roto — pode romper tampão. Evite palpação brutal da massa.

Para a prova — escalas e macetes

Lembre - Para a prova — escalas e macetes

AAA: diâmetro e sintomas definem eletivo vs ruptura. Hipotensão + dor lombar/abdominal + massa pulsátil = ruptura até prova em contrário.

Corte clássico de reparo eletivo ~"e5,5 cm (&B) ou crescimento rápido; ruptura = sala/endovascular de urgência.

AAA - conduta por cenário

Assintomático / sintomático / ruptura

Assintomático

USG/TC surveillance
Reparo se $\geq 5,5$ cm
Ou cresce $\geq 0,5$ -1 cm/ano

Eletivo

Sintomático

Dor / embolização
Internar
Reparo precoce

Urgente

Ruptura

Choque + dor + massa
Volume prudente
EVAR/cirurgia já

Emergência

Critérios de ruptura / alta suspeita

- Tríade: dor abdominal/lombar + hipotensão + massa pulsátil
- Síncope, anemia aguda, equimose de flanco (Grey Turner) em contexto compatível
- Instável com alta suspeita: não atrase transferência à sala por TC 'completa'

Indicações de reparo (ideia de prova)

Indicação | Detalhe

Diâmetro | Geralmente $\geq 5,5$ cm em homens; limiar menor em mulheres em muitas diretrizes

Crescimento | Rápido (ex.: $\geq 0,5$ cm/6 meses ou ≥ 1 cm/ano)

Sintomático | Dor atribuível, embolia distal, inflamatório

Roto / iminente | Cirurgia/EVAR de emergência

Reanimação na ruptura

Dica - Reanimação na ruptura

Hipotensão permissiva cautelosa (evitar hipertensão e sobrecarga) até o controle do sangramento — conceito clássico.

Rastreio

Lembre - Rastreio

Homem idoso tabagista: USG de rastreio é tema frequente. Controle de HAS e cessação do tabaco reduzem risco.

Material de estudo para residência (R1). Não substitui protocolo institucional nem conduta clínica.

www.medhubr1.com.br - MedHub R1